



GUIA PARA PACIENTES

Dor ciática: o que fazer e o que evitar

quando a dor desce pela perna

Por que a dor desce pela perna, o que costuma ajudar, o que costuma atrapalhar e quais sinais não dá para esperar.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **CIATICO**

Para quem é:

Para quem tem uma dor que sai da parte de baixo das costas ou do glúteo e **desce pela perna**, às vezes até o pé, com ou sem dor nas costas, **sem queda forte nem batida** e **sem nenhum dos sinais de alerta da próxima página**.

Se a sua dor fica **só nas costas**, o guia certo é outro: o da palavra **LOMBAR**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem operou a coluna há pouco tempo.
- Gestantes: converse com o seu médico antes de seguir as orientações deste guia.
- Quem tem dor descendo pela perna há mais de 3 meses e nunca foi examinado. Aqui o guia não basta: procure avaliação.

O que você vai precisar:

- Dois travesseiros a mais.
- Uma cadeira ou banquinho firme (para a posição de alívio da Página 6).
- Um tênis confortável.
- Este guia e uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Se, ao se mexer, a dor **recua** da perna para perto da coluna, costuma ser bom sinal.

Se ela **avança** para mais longe na perna, ou o formigamento aumenta, pare aquele movimento.

(Opinião clínica, muito usada na prática de consultório e de fisioterapia.)

Na dor ciática, os sinais que importam são os de **nervo sofrendo demais**.
Leia esta página antes de qualquer outra.

Procure um pronto-socorro HOJE se você tiver:

- **Perda do controle da urina ou das fezes**, dificuldade nova para urinar ou não sentir a bexiga cheia.
- **Dormência na região "da sela"**: entre as pernas, ao redor do ânus e dos genitais.
- **Dor ou formigamento nas DUAS pernas** junto com algum dos sinais acima.

Esses sinais podem indicar compressão grave dos nervos no fim da coluna (síndrome da cauda equina). É raro, mas é urgência [1][7].

Procure avaliação médica no mesmo dia ou em poucos dias se:

- Aparecer **fraqueza na perna ou no pé**: o pé "batendo" no chão ao andar, tropeçar sem motivo, não conseguir ficar na ponta dos pés ou nos calcanhares. **Se a fraqueza está piorando, é no mesmo dia.**
- A dor é tão forte que **não alivia com nenhuma posição**.
- Há **febre, câncer** (mesmo antigo), **perda de peso sem querer**, trauma importante, **osteoporose** ou uso prolongado de **corticoide**.

Uma observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, prova doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes**, e não para assustar [7].

O nervo ciático é formado por **raízes nervosas** que saem da parte de baixo da coluna. Ele passa pelo glúteo, desce pela parte de trás da coxa e se ramifica até o pé.

Quando uma dessas raízes fica **irritada e inflamada**, o cérebro sente a dor **no caminho do nervo**, longe da coluna. A causa mais comum é a **hérnia de disco** [2]. Existem outras, menos comuns, que o exame ajuda a diferenciar.

Nem toda dor na perna é "ciático"

- **Dor referida:** vem das articulações, do disco ou dos músculos da coluna, **sem nervo comprimido**. É profunda, difusa, "pesada", difícil de apontar com o dedo, e costuma ficar no glúteo e na coxa [2].
- **Dor radicular (a ciática de verdade):** vem da raiz nervosa. É em **choque, pontada ou queimação**, percorre uma **faixa estreita** da perna e pode vir com formigamento [2].
- **Radiculopatia:** quando, além da dor, o nervo **conduz mal**: dormência numa área definida, perda de força ou de reflexo. Isso se confirma **no exame físico** [2].

Na prática, dor que passa do joelho e chega ao pé fala mais a favor de raiz nervosa (*opinião clínica*).

Diferenciar uma da outra é trabalho do exame, não do autodiagnóstico.

Um detalhe que o cirurgião de joelho vê muito: dor "no joelho" às vezes vem da coluna ou do quadril. Por isso, quando a dor não se explica pelo joelho, o exame começa pela coluna (*opinião clínica*).

A boa notícia, com honestidade

- Num estudo com 183 pessoas com dor ciática atendidas por clínicos, cerca de **2 em cada 3 relataram melhora em 2 semanas**, e **87% em 12 semanas** [3].
- Num estudo holandês com 283 pessoas com ciática forte havia 6 a 12 semanas, a chance de se sentir recuperado **em 1 ano foi de 95%**, tanto em quem operou cedo quanto em quem esperou. Detalhe importante: **39% de quem esperou acabou operando** [12].

O lado que ninguém conta

Nem todo mundo melhora rápido. Num estudo inglês com cerca de 600 pessoas com dor na perna vinda das costas, **só 55% tiveram melhora importante em 12 meses**. Quem já tinha dor havia mais tempo e quem acreditava que o problema ia durar muito tenderam a melhorar menos [5].

E a hérnia, some?

Muitas vezes o corpo **reabsorve parte da hérnia**. Uma revisão estimou regressão espontânea em 96% das hérnias sequestradas, 70% das extrusas, 41% das protrusas e 13% dos abaulamentos [6]. Ou seja: quanto mais o pedaço de disco "saiu", maior a chance de o corpo reabsorver. São estudos pequenos e variados, então os números são aproximados.

Tradução: para a maioria, o tempo trabalha a favor. Para a minoria que não melhora, existe tratamento, e o caminho começa por uma avaliação.

1. Manter-se ativo, dentro do tolerável

Ficar de cama **não acelera** a melhora da ciática. No estudo das 183 pessoas, repouso no leito e "vida normal com cautela" tiveram resultados iguais [3]. Uma revisão Cochrane encontrou pouca ou nenhuma diferença entre as duas orientações na ciática [4].

Como a cama não traz vantagem e cobra um preço (rigidez, perda de condicionamento, afastamento), a diretriz inglesa orienta **manter as atividades possíveis** [1]. Deitar quando a dor aperta, tudo bem. Passar dias deitado, não.

2. Posições de alívio (*opinião clínica*)

- **Deitado de barriga para cima, pernas apoiadas numa cadeira**, com quadril e joelhos dobrados em ângulo reto.
- **De lado, sobre o lado sem dor**, joelhos dobrados e um travesseiro entre eles.
- **Sentado, por pouco tempo**: cadeira firme, apoio na lombar, levantar a cada 20 a 30 minutos. Na dor de hérnia, ficar sentado costuma piorar.

3. Caminhada curta e frequente (*orientação prática*)

De 5 a 10 minutos, várias vezes ao dia, em terreno plano e passos curtos. Se a dor descer mais na perna, **reduza o tempo, não abandone**. Não há estudo específico que compare caminhada com outras atividades na ciática.

4. Calor local

Pode trazer conforto. Na ciática, porém, faltam bons estudos. Pano entre a bolsa e a pele, e nunca dormir em cima dela.

Este guia não indica remédio nem dose. Quem decide é o seu médico, conforme idade, estômago, rins, pressão e os remédios que você já usa.

O que as pesquisas mostram, em termos gerais:

- **Pregabalina** (remédio para dor de nervo): no principal estudo na ciática, com 209 pessoas, **não foi melhor que o placebo** na dor da perna em 8 semanas nem em 1 ano, e causou **mais efeitos colaterais**, principalmente tontura [8]. A diretriz inglesa não recomenda esse grupo de remédios (gabapentinoides) na ciática [1].
- **Corticoide em comprimido**: em 269 pessoas com hérnia de disco, **melhorou um pouco a função, não melhorou a dor** em 3 semanas, e os efeitos colaterais quase dobraram (49% contra 24%) [9]. A diretriz inglesa também não recomenda [1].
- **Anti-inflamatórios**: evidência de qualidade **muito baixa**. Na dor, não superaram o placebo de forma significativa; na sensação geral de melhora, ganho pequeno; e mais efeitos colaterais [10]. O médico pode considerar em casos selecionados.
- **Calmantes do tipo benzodiazepínico**: não recomendados [1]. **Opioides** (grupo da morfina): não são primeira escolha, e a diretriz inglesa desaconselha na ciática que já dura meses [1].

Isso não quer dizer que nenhum remédio sirva para ninguém. Quer dizer que o benefício médio é pequeno e o risco é real. A decisão é individual.

Não use o remédio de outra pessoa nem repita uma receita antiga sem falar com o seu médico.

Infiltração na coluna (epidural com corticoide)

Uma revisão Cochrane com 25 estudos e 2.470 pessoas mostrou que ela é **um pouco melhor que o placebo** na dor da perna, **a curto prazo**, com efeito pequeno, que pode nem ser percebido como importante [11]. A diretriz inglesa admite considerar na **ciática aguda e intensa** [1].

Tradução: pode ser uma ponte numa crise forte e selecionada. Não é tratamento de rotina.

Cirurgia (retirada da hérnia)

- No estudo holandês de 283 pessoas, operar cedo **aliviou a dor da perna mais rápido**. Em 1 ano, **não houve diferença geral na incapacidade** entre operar cedo e esperar [12].
- Uma metanálise de 2023 mostrou vantagem da cirurgia na dor e na função **a curto prazo**, com **benefício que diminui com o tempo**. A certeza dessa evidência é baixa a muito baixa [13].
- A diretriz inglesa admite considerar cirurgia quando o tratamento não cirúrgico **não melhorou a dor ou a função** e a **imagem combina com os sintomas** [1].

Quando a cirurgia deixa de ser escolha

Nos sinais de cauda equina e na fraqueza importante ou que piora, a avaliação cirúrgica é urgente (Página 3). Fora dessas situações, quase sempre há tempo para decidir com calma (*consenso clínico*).

A indicação de cirurgia de coluna é do cirurgião de coluna, decidida **junto com o paciente**.

Dias 1 e 2 — Acalmar

- Posições de alívio da Página 6 quando a dor apertar.
- Caminhadas de 3 a 5 minutos, várias vezes ao dia.
- Sentado, levantar a cada 20 a 30 minutos.
- Rer a Página 3.

Dias 3 e 4 — Ampliar com calma

- Caminhadas de 5 a 10 minutos, várias vezes.
- Tarefas leves da casa e do trabalho, sem carregar peso.

Dias 5 a 7 — Voltar à rotina possível

- Caminhadas de 10 a 20 minutos, se a dor permitir.
- Retomar o máximo da rotina, com pausas.
- **Dia 7, balanço:** melhorando? Siga. Igual, pior ou com fraqueza? Página 11.

As durações são um ponto de partida prático, não números testados em estudo. O objetivo é progredir, não sofrer.

Rastreador

	Dor na perna (0–10)	Dor nas costas (0–10)	Até onde desce? (glúteo / coxa / abaixo do joelho / pé)	Formigamento ou fraqueza? (S/N)	Caminhada total (min)	Sono (bom / médio / ruim)
Dia 1						
Dia 2						
Dia 3						
Dia 4						
Dia 5						
Dia 6						
Dia 7						

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. A coluna "até onde desce" diz muito ao médico.

1. Ficar dias de cama "até passar".

Não acelera a melhora da ciática [3][4] e atrasa a volta à rotina.

2. Passar horas sentado.

Sofá, carro, computador. Na dor de hérnia, ficar sentado muito tempo costuma piorar. Levante com frequência (*opinião clínica*).

3. "Puxar o nervo" com alongamento forte.

Esticar com força a parte de trás da perna, no auge da dor, costuma irritar ainda mais a raiz nervosa (*opinião clínica*).

4. Exigir ressonância na primeira semana.

Sem sinal de alerta, a diretriz não recomenda exame de imagem de rotina fora do especialista. Ele é pedido quando o resultado vai **mudar a conduta**, como antes de uma infiltração ou cirurgia [1].

5. Empilhar remédios ou usar receita de outra pessoa.

Mais remédio não é mais alívio, e o risco aumenta (Página 7).

6. Comemorar a melhora da dor e ignorar a fraqueza.

Dor que diminui enquanto o pé fica mais fraco **não é melhora**: é sinal para avaliação rápida (*consenso clínico*).

Procure avaliação médica se:

- **Não houver melhora clara em cerca de 2 semanas**, ou a dor **durar mais de 4 a 6 semanas**.
- O **formigamento ou a dormência** não passam ou aumentam.
- Surgir **qualquer perda de força**, mesmo leve.
- A dor **impede dormir ou trabalhar**.
- As crises **se repetem**.
- **A qualquer momento**: aparecer algum sinal da Página 3.

Os prazos acima são de bom senso clínico, coerentes com o curso natural da Página 5 [3][5]. Não são uma regra rígida.

Quando é caso de especialista em coluna

- Fraqueza importante ou que piora, ou sinais de cauda equina (urgência).
- Dor que **não melhora com tratamento não cirúrgico bem conduzido** e exame de imagem que **combina com os sintomas**. É nesse ponto que se discute infiltração ou cirurgia [1].
- Dúvida sobre a origem da dor.

Se quiser uma avaliação

Na consulta, a avaliação é feita **com exame físico**: história, força, sensibilidade, reflexos, testes de tensão do nervo, e exame do **quadril e do joelho**, porque dor na perna nem sempre vem da coluna. A partir daí se organiza o tratamento inicial e, **quando indicado, o encaminhamento ao especialista em coluna**, que faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: [@robertorodriguesmd](https://www.instagram.com/robertorodriguesmd)

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). **Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management**. NICE guideline NG59. Publicada em 30/11/2016; atualizada em 2020 e em 2026. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng59>
2. Bogduk N. **On the definitions and physiology of back pain, referred pain, and radicular pain**. Pain. 2009;147(1-3):17-19. doi:10.1016/j.pain.2009.08.020. PMID: 19762151.
3. Vroomen PC, de Krom MC, Wilmink JT, Kester AD, Knottnerus JA. **Lack of effectiveness of bed rest for sciatica**. N Engl J Med. 1999;340(6):418-423. doi:10.1056/NEJM199902113400602. PMID: 9971865.
4. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. **Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica**. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (6):CD007612. doi:10.1002/14651858.CD007612.pub2. PMID: 20556780.
5. Konstantinou K, Dunn KM, Ogollah R, et al. **Prognosis of sciatica and back-related leg pain in primary care: the ATLAS cohort**. Spine J. 2018;18(6):1030-1040. doi:10.1016/j.spinee.2017.10.071. PMID: 29174459.
6. Chiu CC, Chuang TY, Chang KH, Wu CH, Lin PW, Hsu WY. **The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review**. Clin Rehabil. 2015;29(2):184-195. doi:10.1177/0269215514540919. PMID: 25009200.
7. Finucane LM, Downie A, Mercer C, et al. **International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies**. J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):350-372. doi:10.2519/jospt.2020.9971. PMID: 32438853.
8. Mathieson S, Maher CG, McLachlan AJ, et al. **Trial of pregabalin for acute and chronic sciatica**. N Engl J Med. 2017;376(12):1111-1120. doi:10.1056/NEJMoa1614292. PMID: 28328324.
9. Goldberg H, Firtch W, Tyburski M, et al. **Oral steroids for acute radiculopathy due to a herniated lumbar disk: a randomized clinical trial**. JAMA. 2015;313(19):1915-1923. doi:10.1001/jama.2015.4468. PMID: 25988461.
10. Rasmussen-Barr E, Held U, Grooten WJ, et al. **Non-steroidal anti-inflammatory drugs for sciatica**. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10(10):CD012382. doi:10.1002/14651858.CD012382. PMID: 27743405.
11. Oliveira CB, Maher CG, Ferreira ML, et al. **Epidural corticosteroid injections for lumbosacral radicular pain**. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4):CD013577. doi:10.1002/14651858.CD013577. PMID: 32271952.
12. Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, et al; Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group. **Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica**. N Engl J Med. 2007;356(22):2245-2256. doi:10.1056/NEJMoa064039. PMID: 17538084.
13. Liu C, Ferreira GE, Abdel Shaheed C, et al. **Surgical versus non-surgical treatment for sciatica: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials**. BMJ. 2023;381:e070730. doi:10.1136/bmj-2022-070730. PMID: 37076169.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

